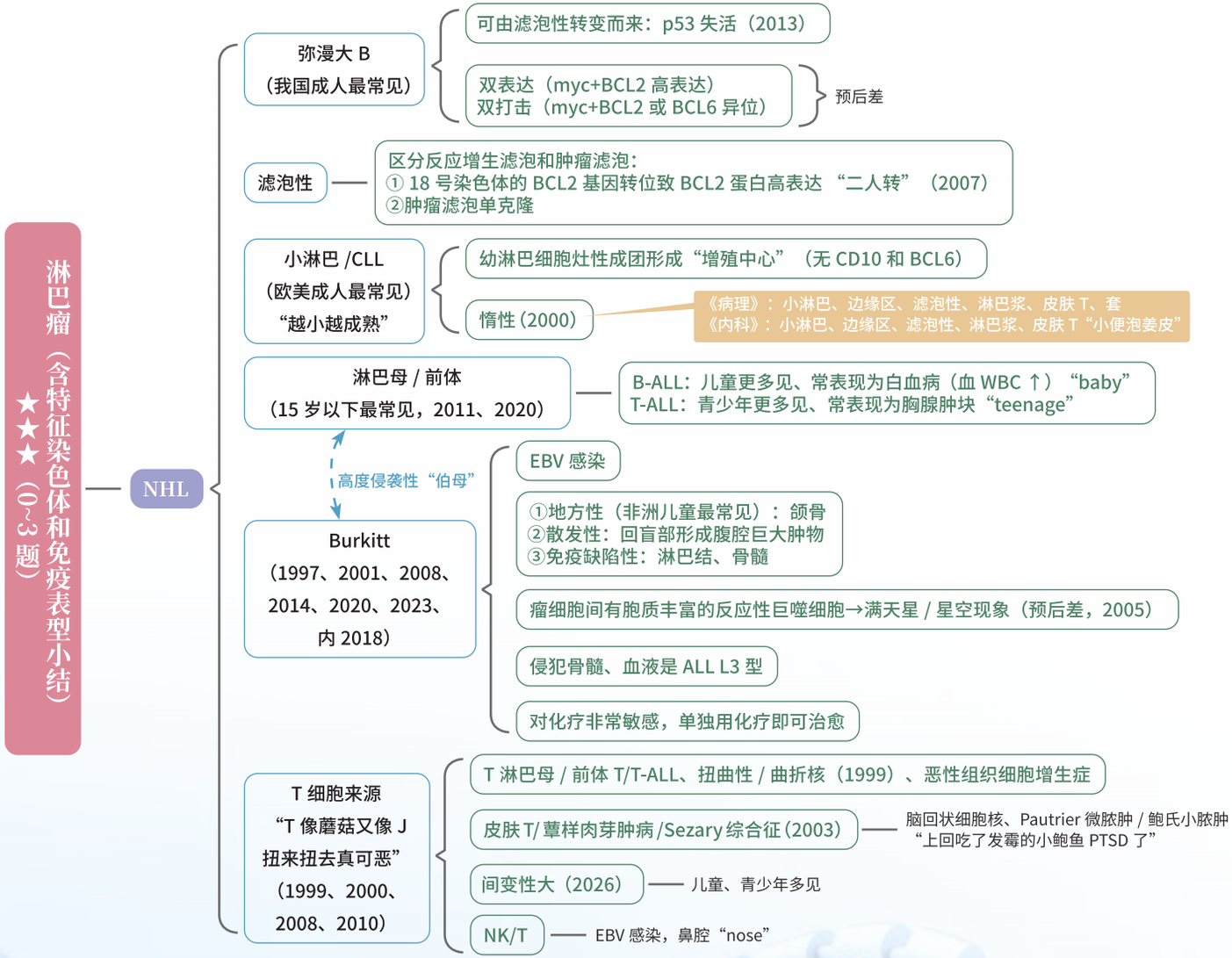

淋巴瘤（含特征染色体和免疫表型小结）
★★★（0~3 题）
NHL
弥漫大 B
（我国成人最常见）
可由滤泡性转变而来：p53 失活（2013）
双表达（myc+BCL2 高表达）
双打击（myc+BCL2 或 BCL6 异位）
预后差
滤泡性
区分反应增生滤泡和肿瘤滤泡：
① 18 号染色体的 BCL2 基因转位致 BCL2 蛋白高表达 “二人转”（2007）
②肿瘤滤泡单克隆
小淋巴 /CLL
（欧美成人最常见）
“越小越成熟”
幼淋巴细胞灶性成团形成“增殖中心”（无 CD10 和 BCL6）
惰性（2000）
《病理》：小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆、皮肤 T、套
《内科》：小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆、皮肤 T “小便泡姜皮”
淋巴母 / 前体
（15 岁以下最常见，2011、2020）
B-ALL：儿童更多见、常表现为白血病（血 WBC ↑）“baby”
T-ALL：青少年更多见、常表现为胸腺肿块“teenage”
高度侵袭性“伯母”
Burkitt
（1997、2001、2008、2014、2020、2023、内 2018）
EBV 感染
①地方性（非洲儿童最常见）：颌骨
②散发性：回盲部形成腹腔巨大肿物
③免疫缺陷性：淋巴结、骨髓
瘤细胞间有胞质丰富的反应性巨噬细胞→满天星 / 星空现象（预后差，2005）
侵犯骨髓、血液是 ALL L3 型
对化疗非常敏感，单独用化疗即可治愈
T 细胞来源
“T 像蘑菇又像 J
扭来扭去真可恶”
（1999、2000、2008、2010）
T 淋巴母 / 前体 T/T-ALL、扭曲性 / 曲折核（1999）、恶性组织细胞增生症
皮肤 T/ 蕈样肉芽肿病 /Sezary 综合征（2003）
脑回状细胞核、Pautrier 微脓肿 / 鲍氏小脓肿
“上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了”
间变性大（2026）
儿童、青少年多见
NK/T
EBV 感染，鼻腔“nose”